

KC桌面——外资精译

Bernstein：礼来口服药新处方连续下滑，GLP1拐点何时到来？

GLP-1追踪：关注新处方，DTC广告和医保开始启动（截至6月26日当周）

专科销售：公司情况更新

本周处方量基本稳定，总处方量环比增长+0.51%，绝对值增加+1.3万。Foundayo TRx环比下降，Wegovy Pill也出现下滑；具体而言，Foundayo在第12周录得19,831张TRx，环比减少762张，降幅-3.7%。Wegovy Pill本周录得14.9万张TRx，环比下降2,500张，降幅约-1.6%。据礼来读者关系部，IQVIA对Foundayo周度数据的捕获率已有所改善，二季度约为~90%（但周度间确有波动）。Zepbound的对应捕获率>90%。在新处方方面，礼来的份额为53.5%，低于上周的54.4%。提醒一下——Foundayo的直接面向消费者广告仍处于早期阶段，我们预计随着全面广告投放后数月内客户/患者认知度的提升，处方量将出现拐点。最后，GLP-1用于肥胖症的医保报销已于上周（7月1日）通过GLP-1

BRIDGE项目启动。我们将在未来几周监测渠道层面的处方量（TRx/NBRx），以评估其影响。

总处方量：周总处方量为260万张，较上周增加（+0.51%，绝对值+1.3万）。司美格鲁肽+替尔泊肽的四周同比增速为33.4%，低于上周的35.1%。按TRx计算的公司市场份额目前为：礼来60.6%（Zepbound 26.9%，Mounjaro 32.9%，Foundayo 0.8%），诺和诺德39.4%（Wegovy笔 12.7%，Ozempic 20.6%，Wegovy Pill 6.0%）。

新处方（NBRx）：所有GLP-1品牌的总新处方量仍维持高位，每周21万张。Foundayo的NBRx目前为1.04万张，而Wegovy Pill为3.82万张，Foundayo自6月12日当周达到1.26万张峰值后已连续下降（图表3）。近几周因假期出现一些扰动，但对于一款早期上市产品而言，也未出现我们所预期的反弹。Wegovy Pill的起始剂量（1.5mg）NBRx似乎呈下降趋势（图表28）。这些是需要关注的数据点，尤其是在更广泛的DTC广告和医保资格开始启动之际。礼来的NBRx份额为53.5%，低于上周的54.4%。

Zepbound：Zepbound本周市场份额基本稳定在26.9%（较上周+0.09个百分点）。四周平均同比增速从57%降至52%。Zepbound绝对处方量环比增加+5,000张。

Mounjaro：本周Mounjaro四周平均同比增速为39.1%，与上周的39.7%大致持平。市场份额从32.7%小幅上升至32.9%，绝对处方量环比增加+10,000张。

司美格鲁肽：增长因适应症和剂型呈现显著分化。Wegovy Pill本周TRx为14.9万张，环比下降2,500张，目前已进入上市第25周。Wegovy笔的四周平均同比增速为37.3%，低于上周的40.8%，Wegovy笔绝对处方量环比增加+1,000张。Ozempic四周平均同比继续下降，为-13.1%，上周为-12.8%。总体而言，司美格鲁肽同比增速为19.8%，低于上周的20.7%。

公司代码表：公司情况更新

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖
来源：彭博、Bernstein估计与分析。

观察提示：公司情况更新

我们给予礼来跑赢大盘评级。

2025年第二季度及2026财年Foundayo估计

定价动态将在多个维度演变——自费患者定价按混合计算可能会上升，因为患者会从低剂量转向高剂量。医保将在下半年成为市场增长更主要的驱动力，一旦BRIDGE/BALANCE生效，所有剂量定价均为249美元；同时，随着三大药品福利管理机构的支付方覆盖范围在6月1日前扩大并正式化，商业价格也将下降。

实际处方数据目前仅涵盖Foundayo上市的前十二周，与全面患者激活（包括线性电视广告）以及BRIDGE/BALANCE项目相关的拐点带来了显著的不确定性。美国以外的上市目前仅在那些参照美国监管的国家（如阿联酋）进行，而关键的早期上市国家（如英国）可能会在第四季度推动美国以外的进一步收入拐点。

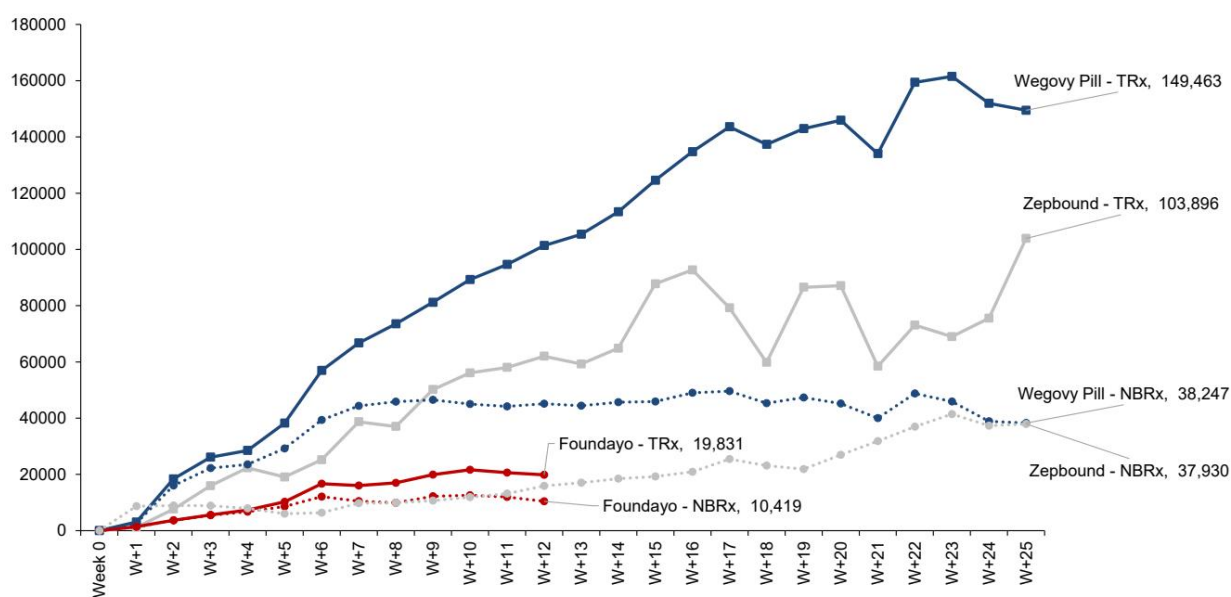
图表1：我们对Foundayo第二季度收入的估计为1.26亿美元，基于混合定价和按渠道划分的IQVIA处方量

来源：IQVIA、Bernstein分析

图表2：Foundayo美国上市进展慢于我们预期——基于处方轨迹，2026财年收入可能在13亿美元范围内

来源：IQVIA、Bernstein分析与估计

图表3：Zepbound、Wegovy Pill、Foundayo上市最初几周的TRx和NBRx



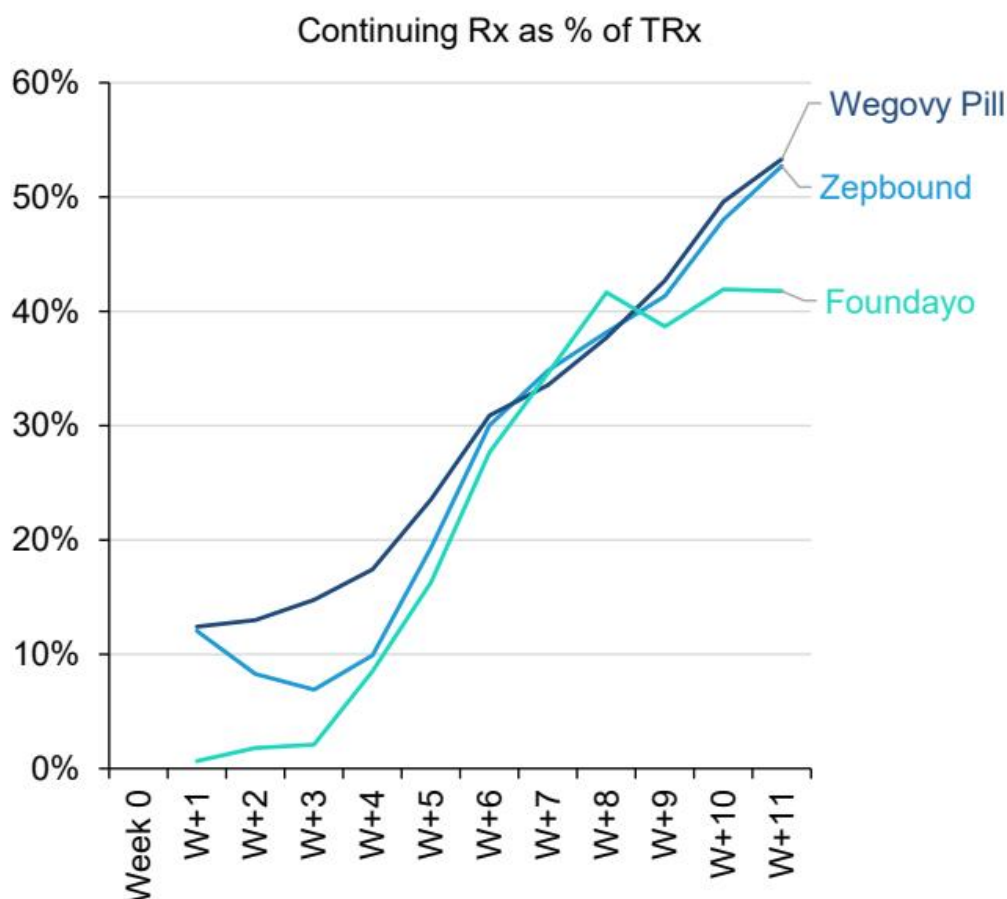
图表 1

来源：IQVIA、Bernstein

图表4：上市最初几周，Zepbound和Wegovy Pill的持续用药患者水平相似，Foundayo在最新数据点略有偏离

来源：IQVIA、Bernstein分析

图表5：虽然此前与Zepbound/Wegovy趋势一致，但近期数据显示Foundayo持续用药患者占总处方量的比例有所下降。鉴于数据可能不完整，需继续监测



图表 2

来源：IQVIA、Bernstein分析

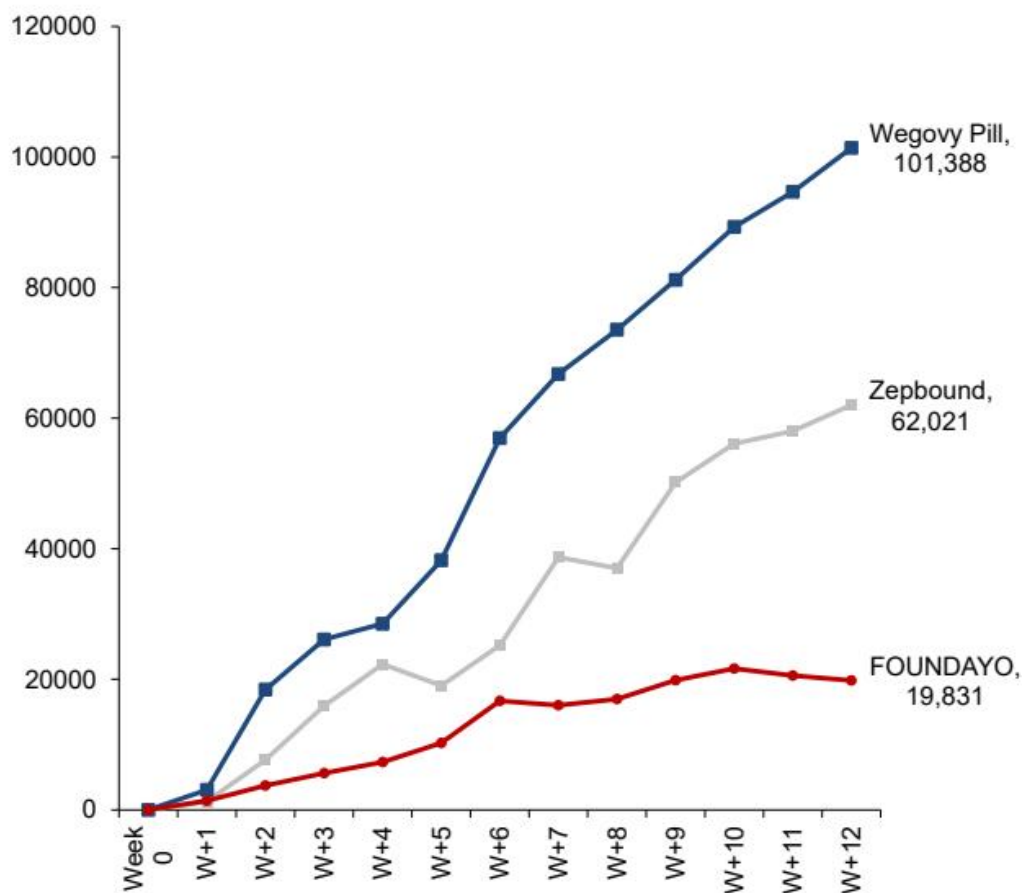
口服GLP-1上市动态

Foundayo早期从每日到每周处方的转换似乎存在相关性（图表12），但每日绝对TRx转换为每周数字的差距仍然很大（图表14）。然而，基于礼来的财报评论，我们仍将口服GLP-1视为市场扩张因素，此前估计IQVIA对Foundayo的捕获率约为~70%。读者关系部现在表示，总体而言，Foundayo在IQVIA中的捕获率目前约为90%。我们同意管理层的看法，即这次上市可能会持续数月而非数周，原因有二：（1）这是一种全新的分子（Wegovy Pill是司美格鲁肽的剂型延伸），需要更多的医生教育；（2）鉴于此，DTC广告在医生得到充分教育之前无法启动，这意味着包括电视广告在内的DTC广告要到第三季度才会全面展开（第二季度末已有少量开始播出——包括在世界杯和NBA总决赛期间）。

在2026年诺和诺德年度股东大会上，诺和诺德（由Justin Smith覆盖）报告称，在第10周，每周Wegovy Pill的TRx是替尔泊肽的3倍，而IQVIA处方数据显示为1.6倍（假设替尔泊肽=Zepbound）。诺和诺德报告的患者/TRx数量可能与我们的数据存在一定差异，原因在于：（1）诺和诺德能获取更及时、更细化的数据；（2）诺和诺德关怀及其他处方可能尚未被IQVIA完全捕获；（3）未来，依从率可能会影响观察到的模式；即低于100%的依从率意味着实际患者数量高于TRx所显示的数量。诺和诺德一直暗示，迄今为止IQVIA对Wegovy Pill的捕获率仅为50%——类似于我们在Lilly Direct推出Zepbound小瓶时看到的低捕获率，并与他们新的3倍替尔泊肽数据相互印证。在2026年第一季度财报电话会议上，礼来报告称迄今约有2万名患者。

EXHIBIT 6:Foundayo 首个处方季的 TRx

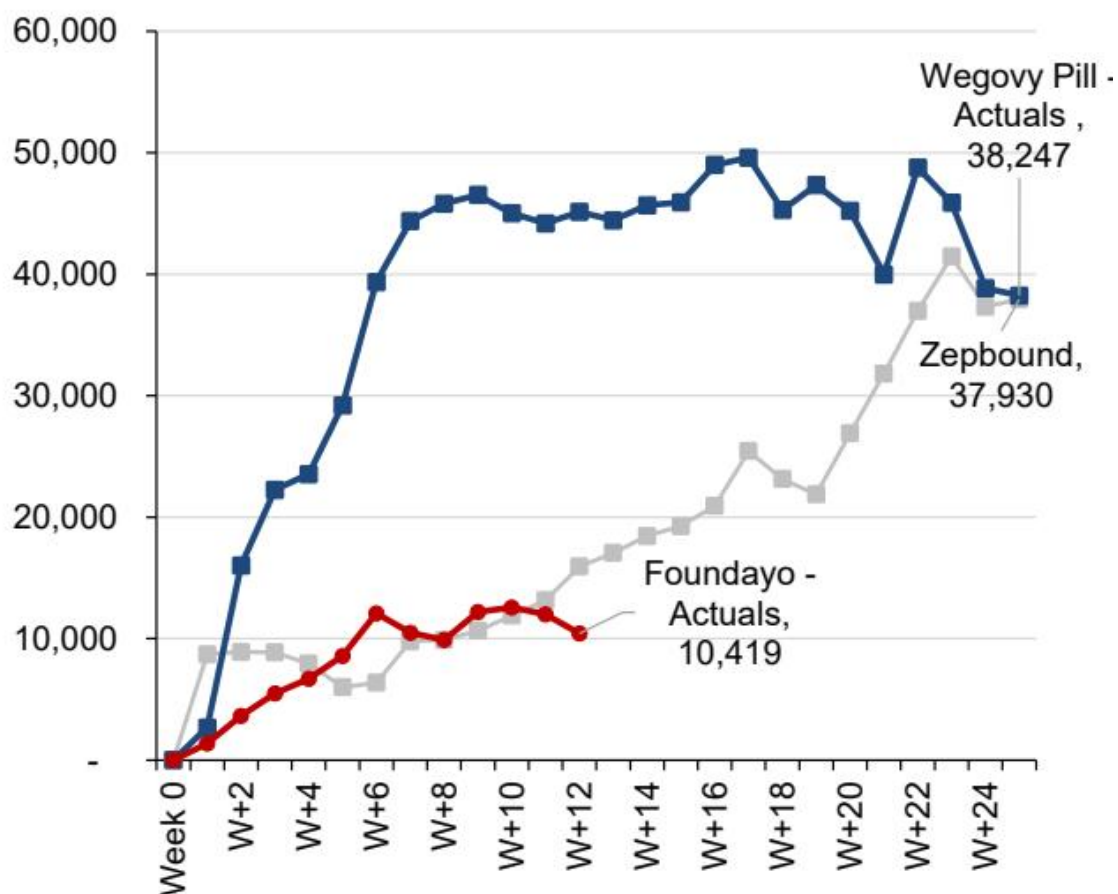
轨迹——表现不及同类药物，但因是首个新分子实体获批而处于相对劣势（Wegovy Pill 和 Zepbound 均为适应症扩展）



图表 3

来源：IQVIA, Bernstein 分析

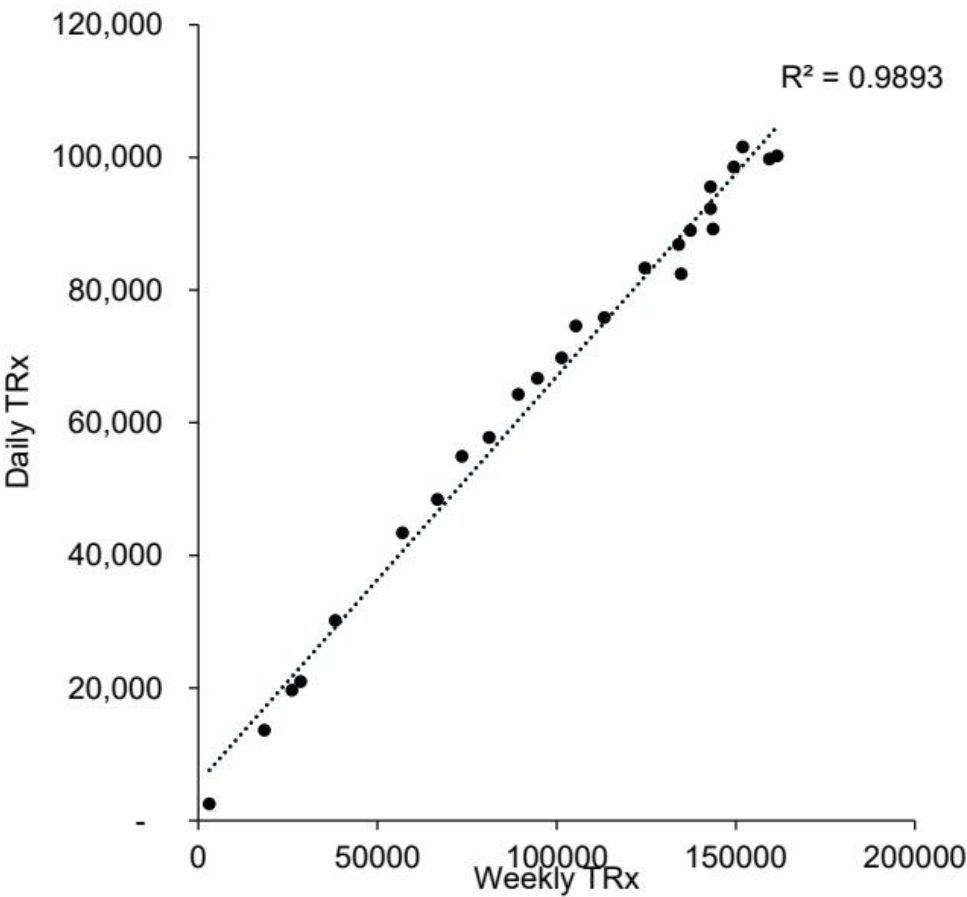
EXHIBIT 7: Wegovy Pill 和 Foundayo 对比 Zepbound 上市情况（新品牌处方 - NBRx；周度）



图表 4

数据截至 6 月 26 日当周 来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 8:每日 TRx 与 IQVIA 收集的周度数据相关性良好



图表 5

来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 9:上市最初几周的处方量（TRx）

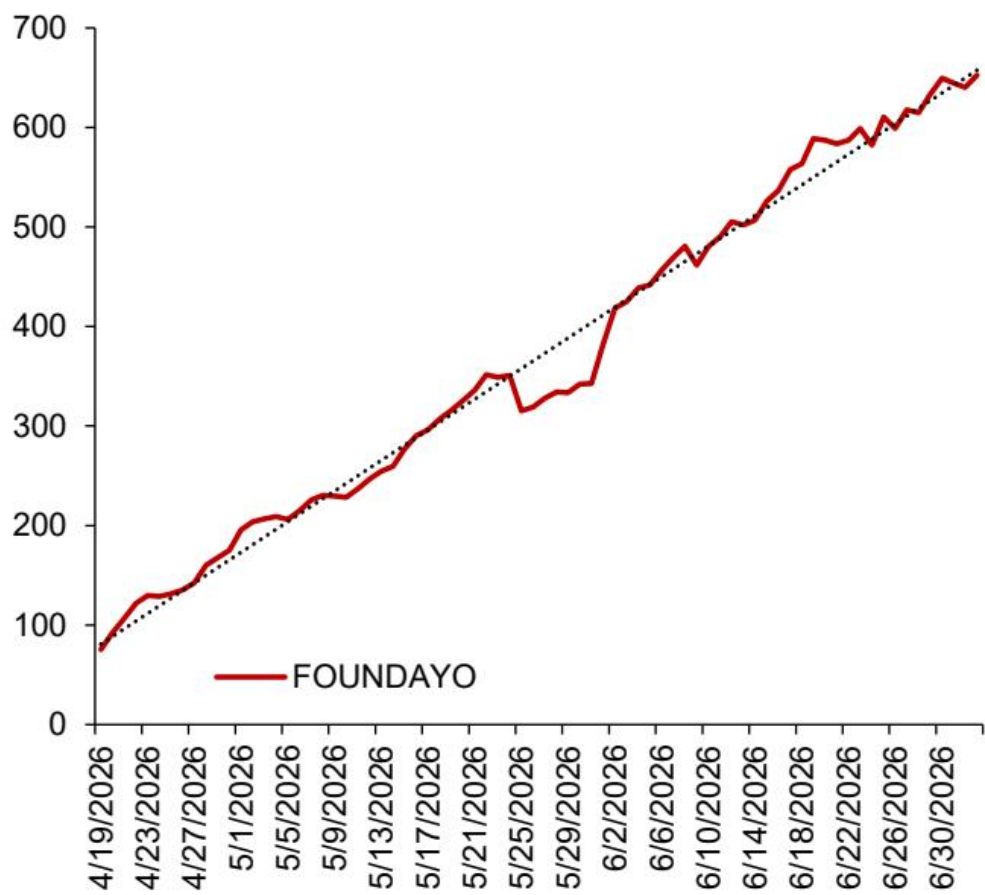
Wegovy Pill 已根据较低的捕获率进行调整（Novo 表示捕获率仅为 50%） 来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 10:Wegovy NBRx 在上市初期似乎比 Foundayo 出现更明显的拐点

基于周度 NBRx 数据 来源：IQVIA, Bernstein 分析

每日数据：公司情况更新

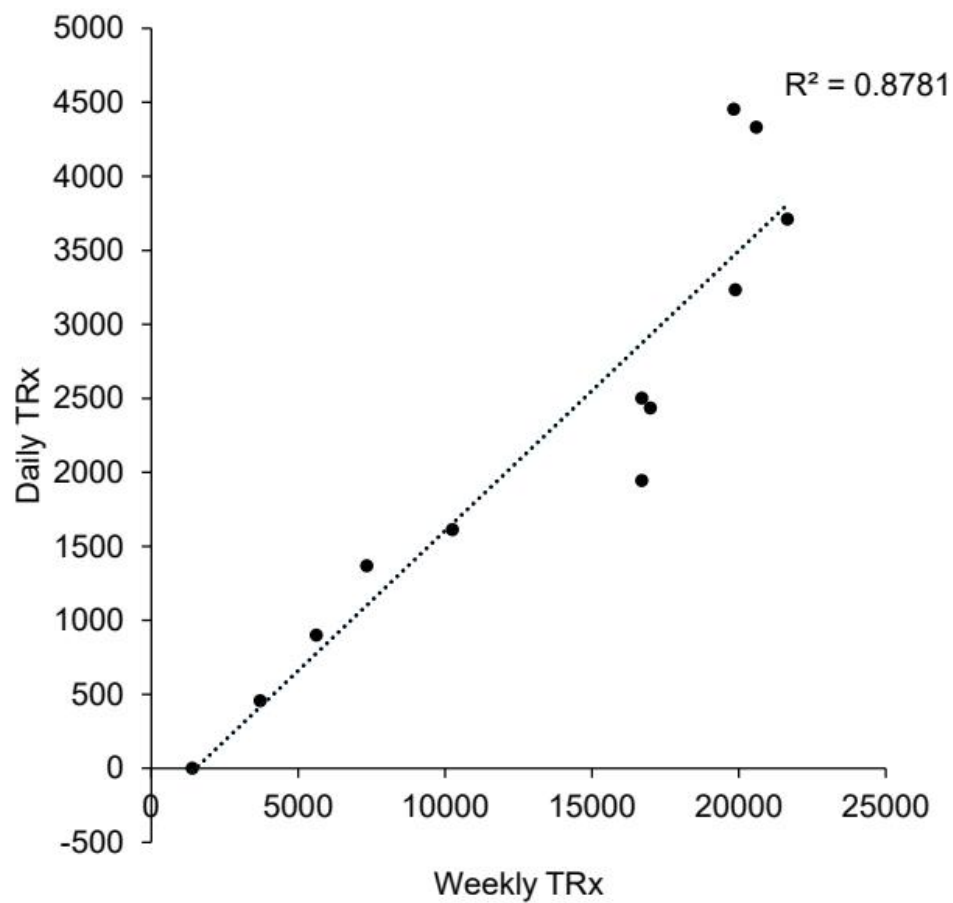
EXHIBIT 11:Foundayo 未经调整的 7 天滚动平均每日处方量



图表 6

来源：IQVIA, Bernstein 分析

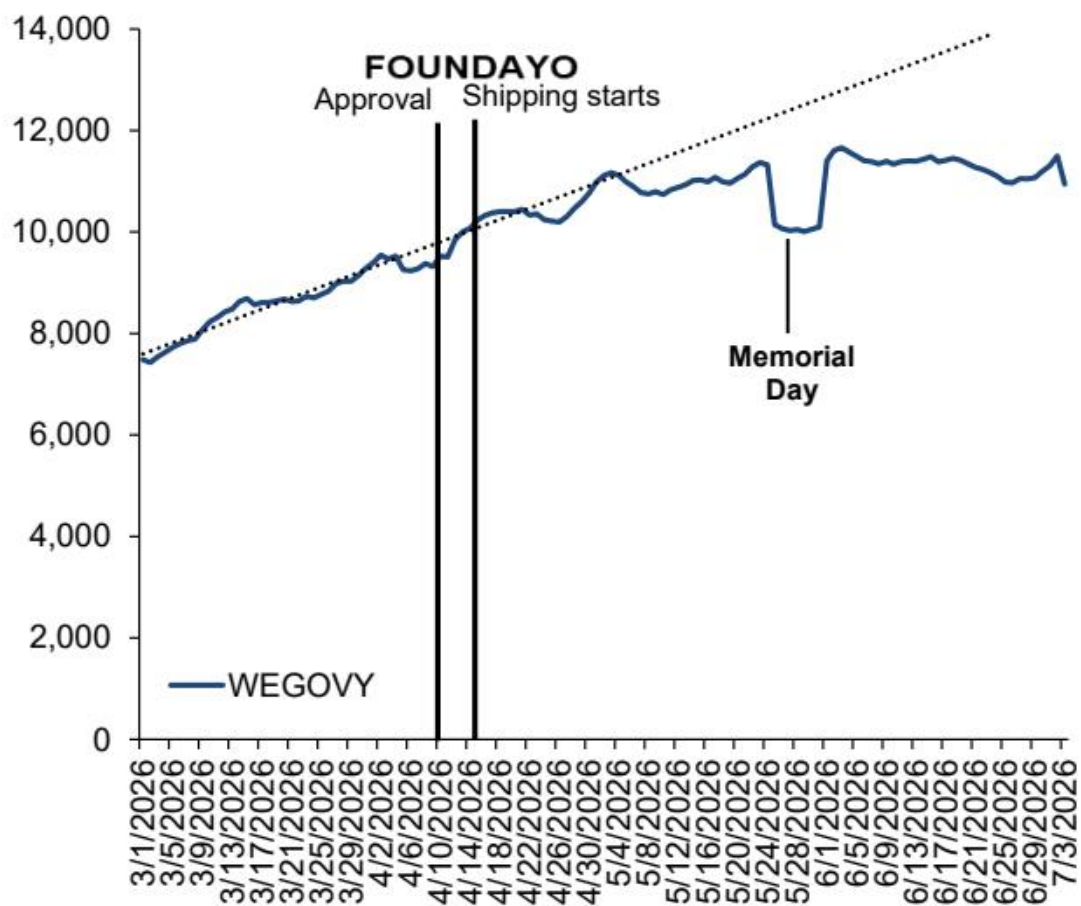
EXHIBIT 12:早期数据点显示，尽管 Foundayo 每日处方量显著较低，但其趋势与周度处方量一致



图表 7

来源：IQVIA, Bernstein 分析

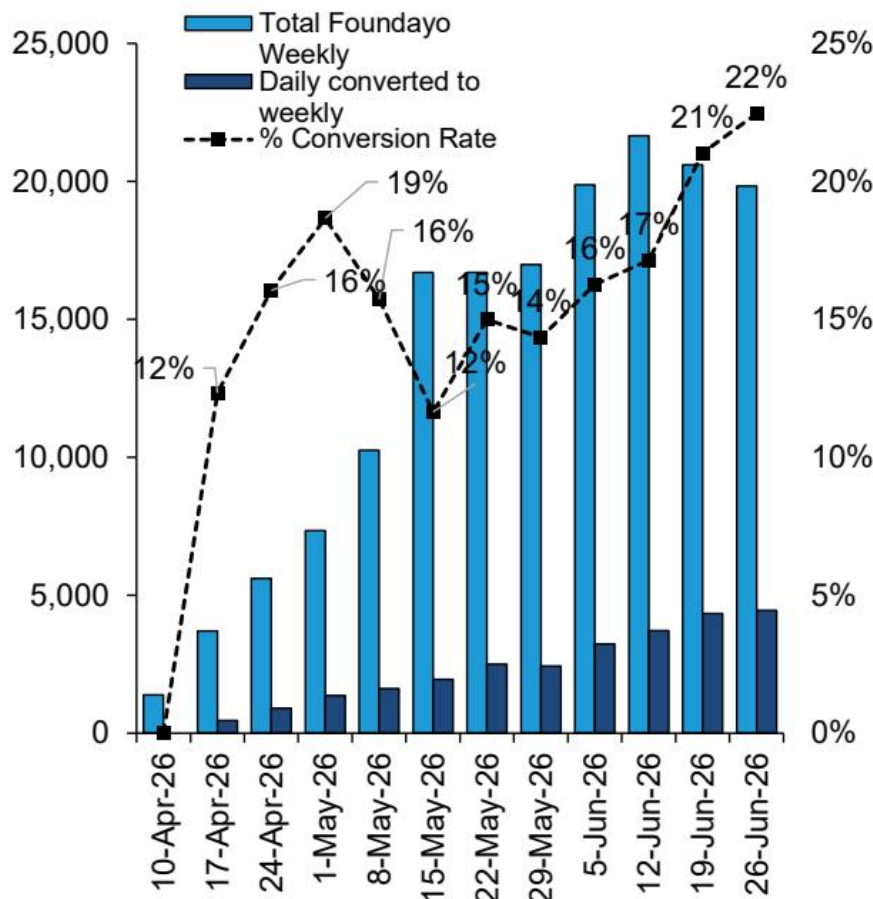
EXHIBIT 13:自 Foundayo 上市以来，Wegovy Pill 的每日 NRx 已趋于平稳



图表 8

来源：IQVIA 每日 TRx, Bernstein 分析

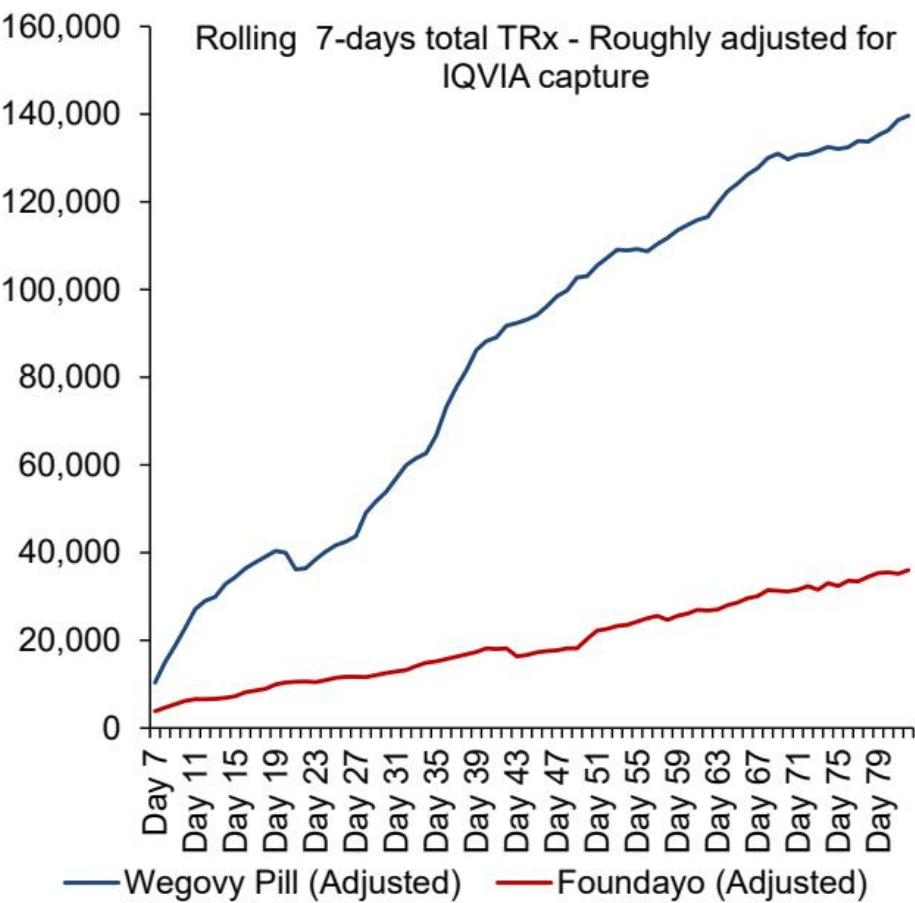
EXHIBIT 14:日度到周度处方转换尚未显示出稳定或方向性的关系



图表 9

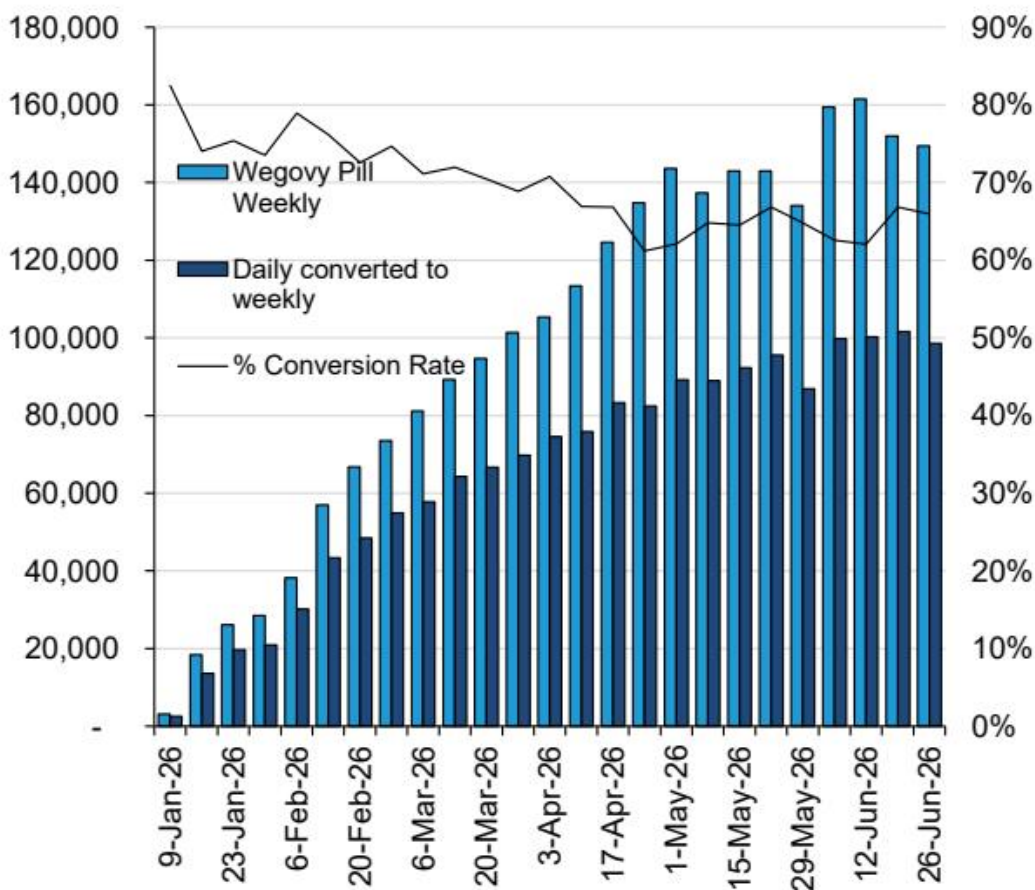
来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 15:从日度处方调整为周度处方，并考虑 IQVIA 的捕获率后，我们看到两种减肥药在上市初期存在巨大差距。然而，随着 Foundayo 新增患者数量的增加，这一差距将在年内收窄



图表 10

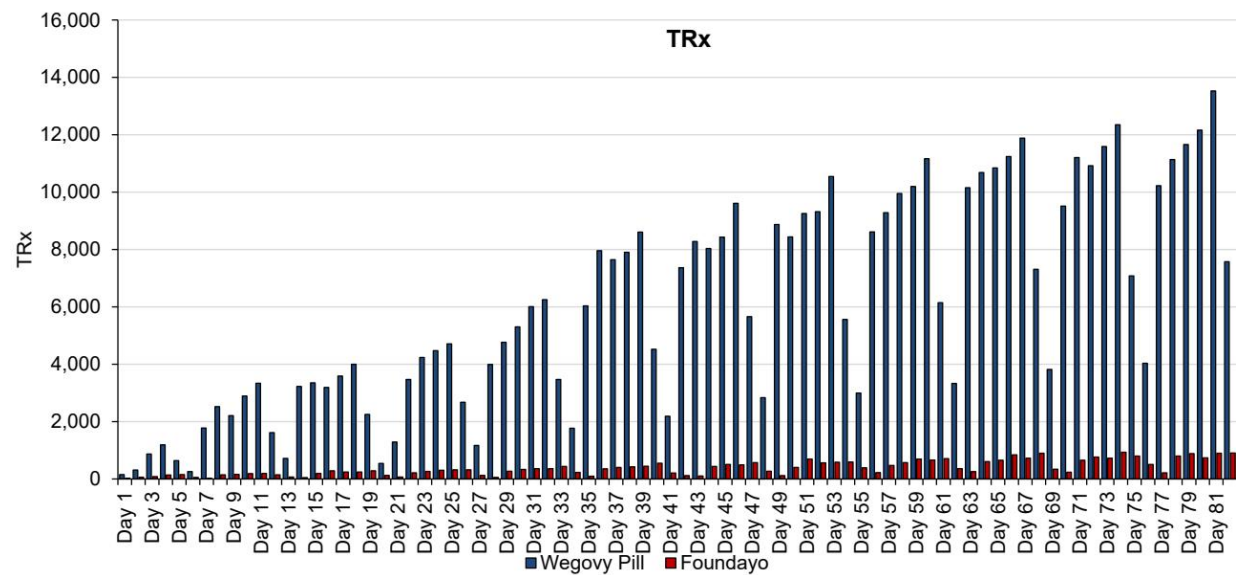
EXHIBIT 16:日度处方量在绝对数值上低于周度，但方向正确



图表 11

来源：IQVIA, Bernstein 分析 来源：IQVIA, Bernstein 分析

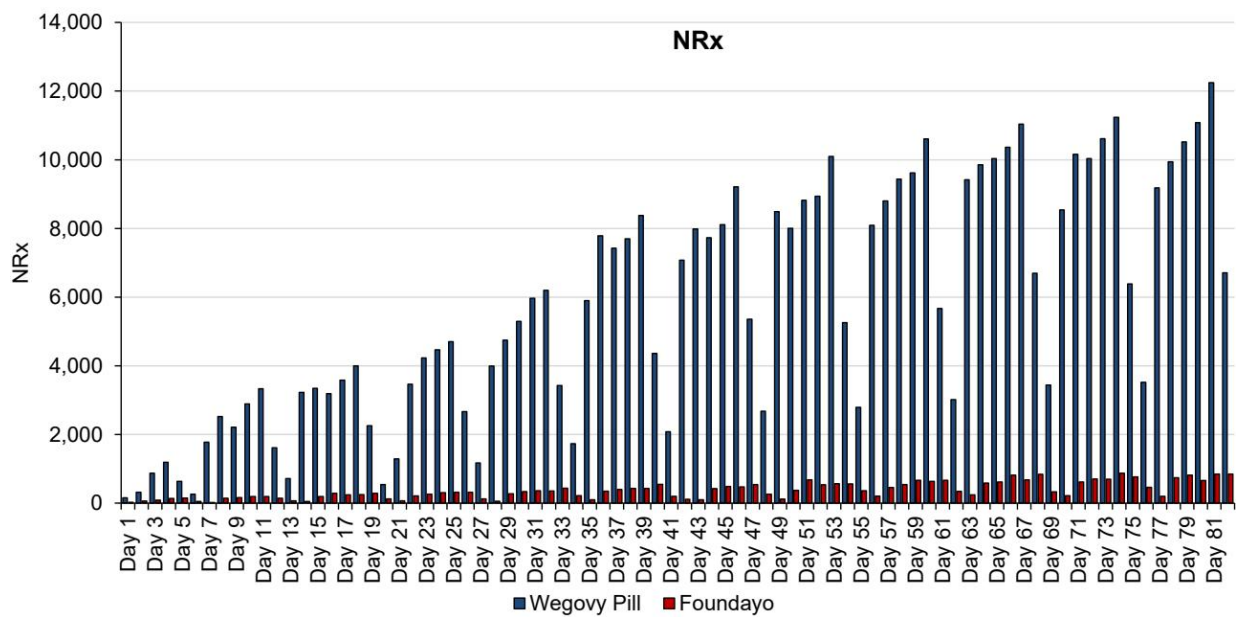
EXHIBIT 17:IQVIA 每日 TRx



图表 12

来源：IQVIA, Bernstein 分析

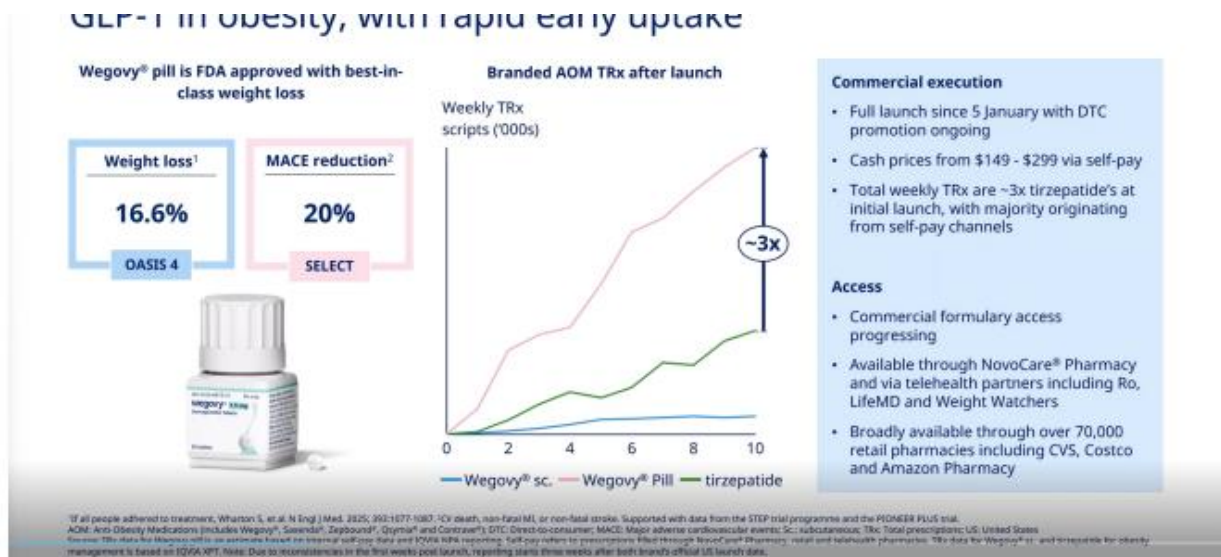
EXHIBIT 18:IQVIA 每日 NRx



图表 13

来源：IQVIA, Bernstein 分析 Wegovy $\text{\$}^{\text{\textcircled{R}}}$ 片剂在美国上市，作为首个且同类最佳的口服 GLP-1 减肥药，早期采用迅速

EXHIBIT 19:在 2026 年 Novo 股东大会上，Novo 报告称，在第 10 周时，Wegovy 片剂的周度 TRx 是 tirzepatide 的三倍



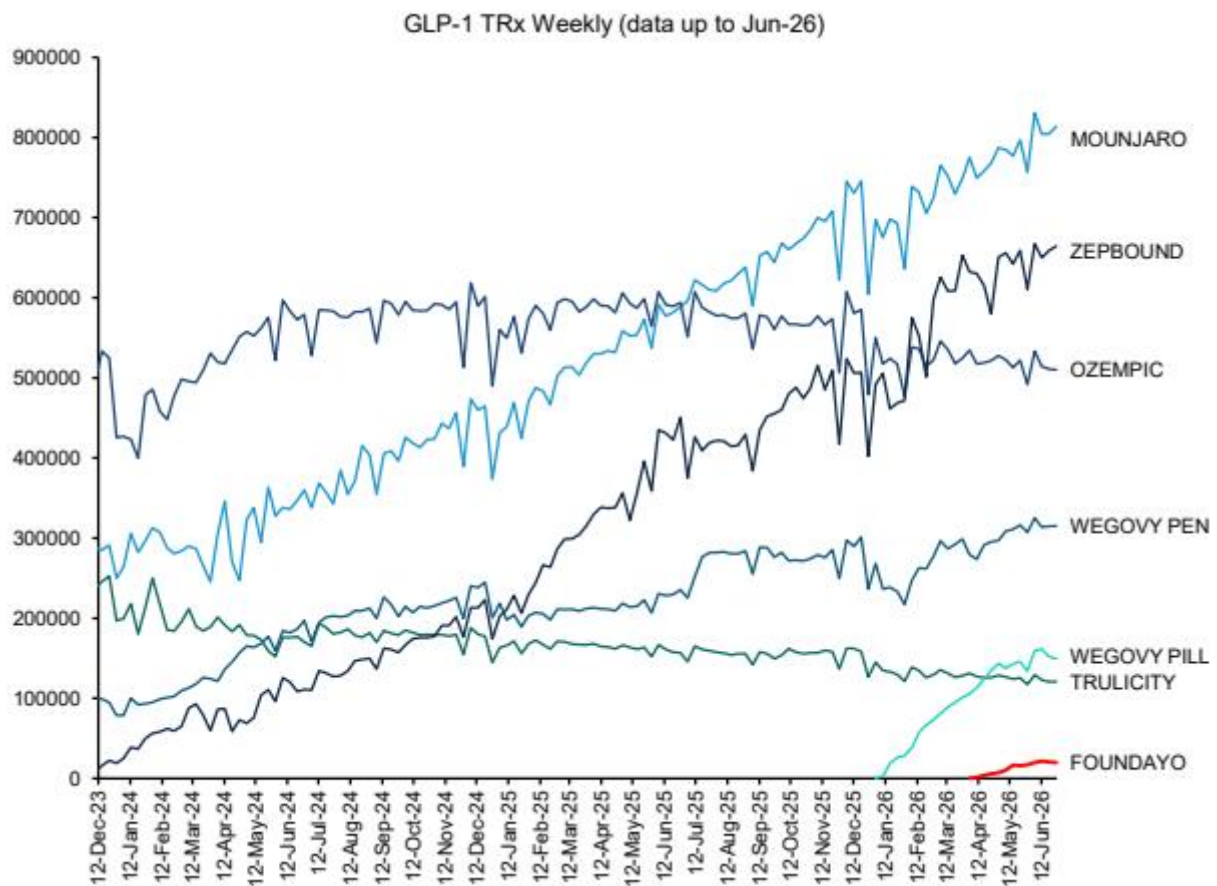
图表 14

来源：Novo 2026 年股东大会

总处方量 (TRX) 与新处方量 (NRX)

TRx 代表总处方量，而 NRx 代表所有新处方（无论针对新患者还是现有患者的续方）。

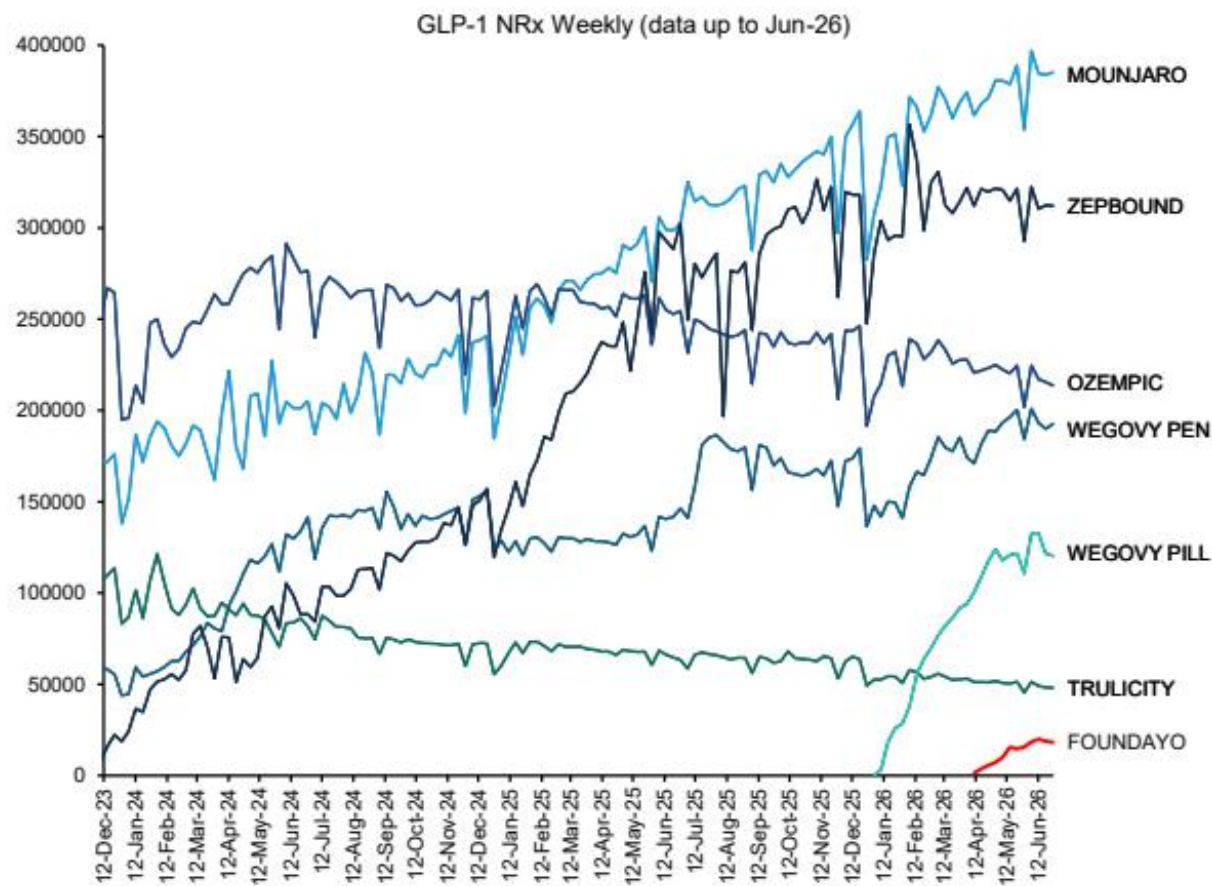
EXHIBIT 20:GLP1 周度 TRx 数据



图表 15

来源：IQVIA, Bernstein 分析

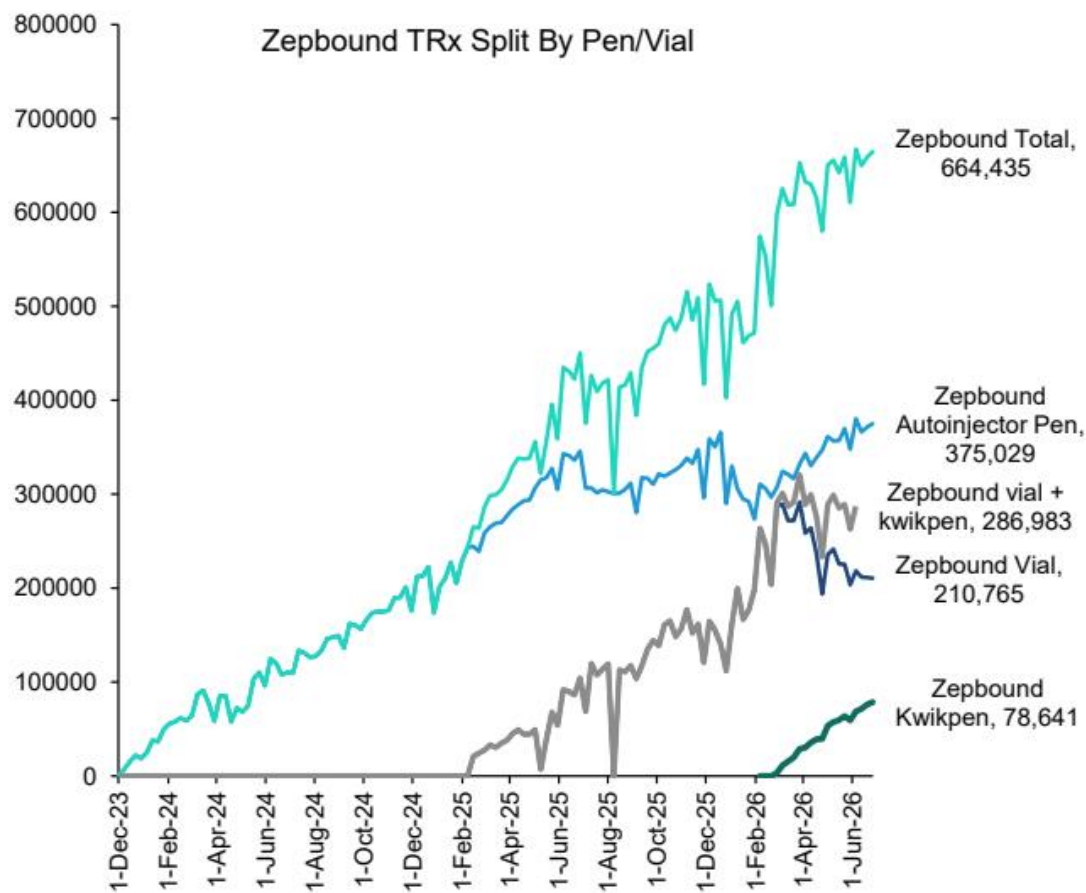
EXHIBIT 21:GLP1 周度 NRx 数据



图表 16

来源：IQVIA, Bernstein 分析

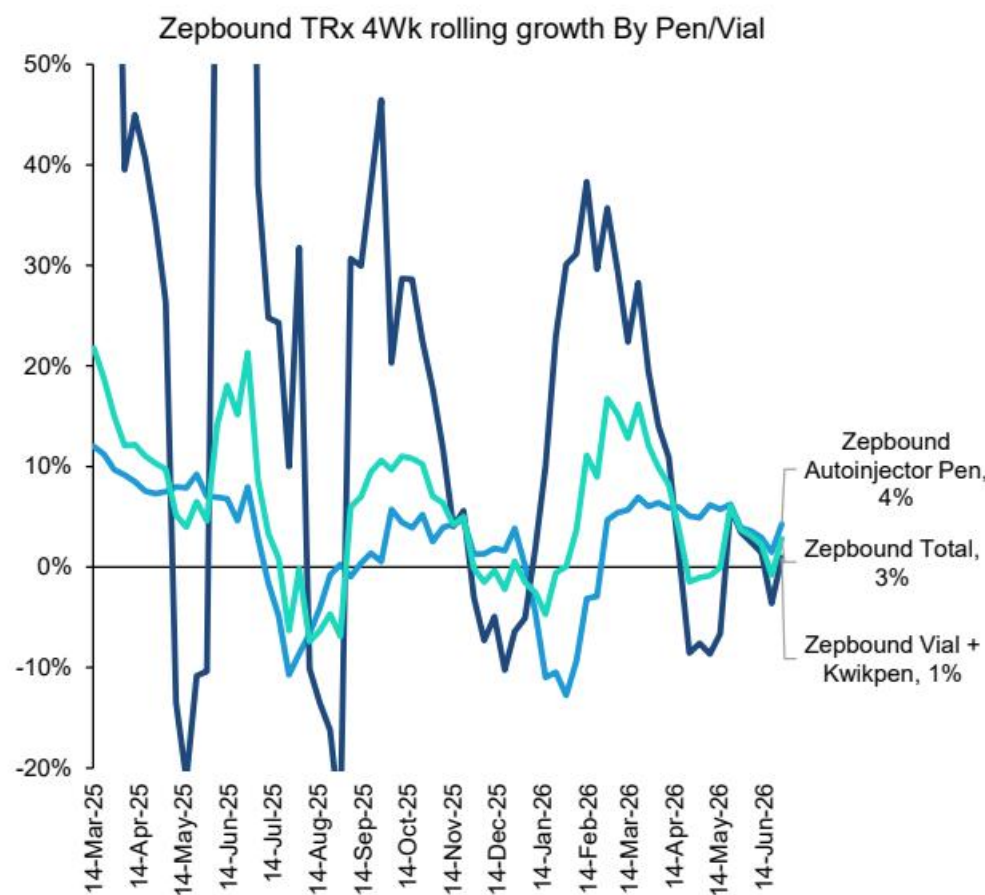
EXHIBIT 22:Zepbound 按剂型划分的周度 TRx 数据



图表 17

Zepbound 瓶装和预充笔通过 LillyDirect DTC 渠道提供 来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 23:Zepbound TRx 按剂型划分的 4 周滚动增长率



图表 18

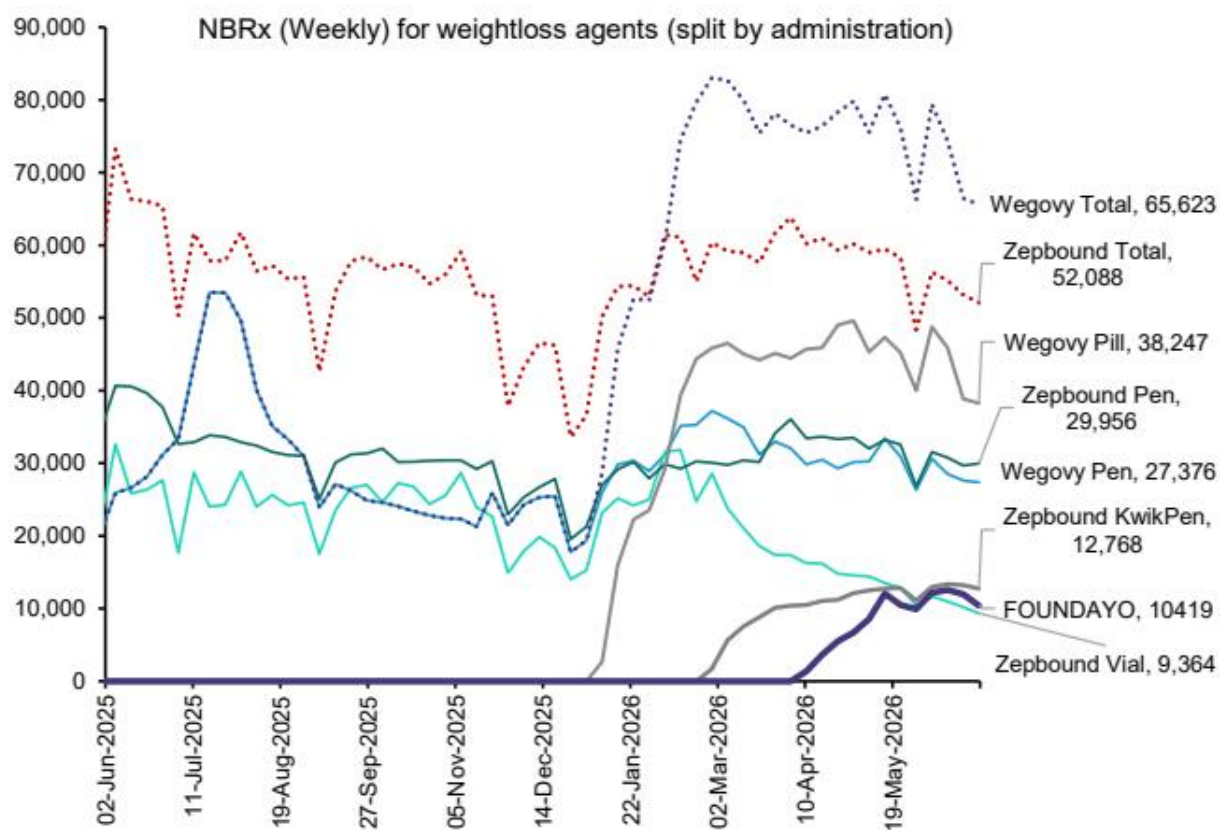
Zepbound 瓶装和预充笔通过 LillyDirect DTC 渠道提供 来源：IQVIA, Bernstein 分析

新品牌处方 (NBRX)

NBRx 数据——新品牌处方仅针对新用户，这些用户在过去的 12 个月内（回溯期）未使用过该品牌（可能是 GLP1 市场的新患者，或从其他品牌转换而来）。这能更准确地反映我们从 CVS Caremark 处方集变更中看到的情况，并提供了市场份额趋势的参考。

请注意，新品牌周度数据的发布滞后于其他周度数据。如果您希望在下周数据发布后的下一次追踪报告之前获得更新图表，请与我们联系。

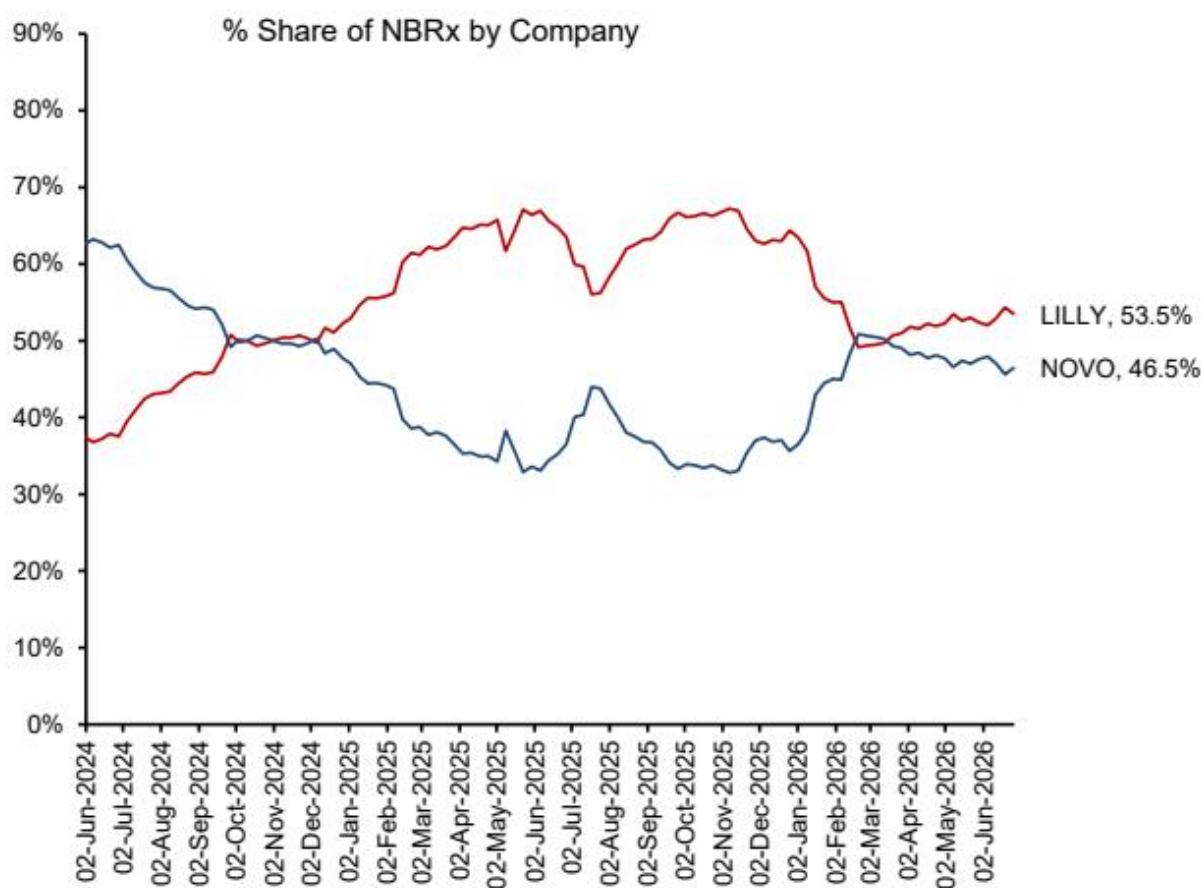
EXHIBIT 24:NBRx——按 Zepbound 的笔式和瓶装划分（对比 Wegovy）



图表 19

数据截至 6 月 26 日当周 来源：IQVIA, Bernstein 分析

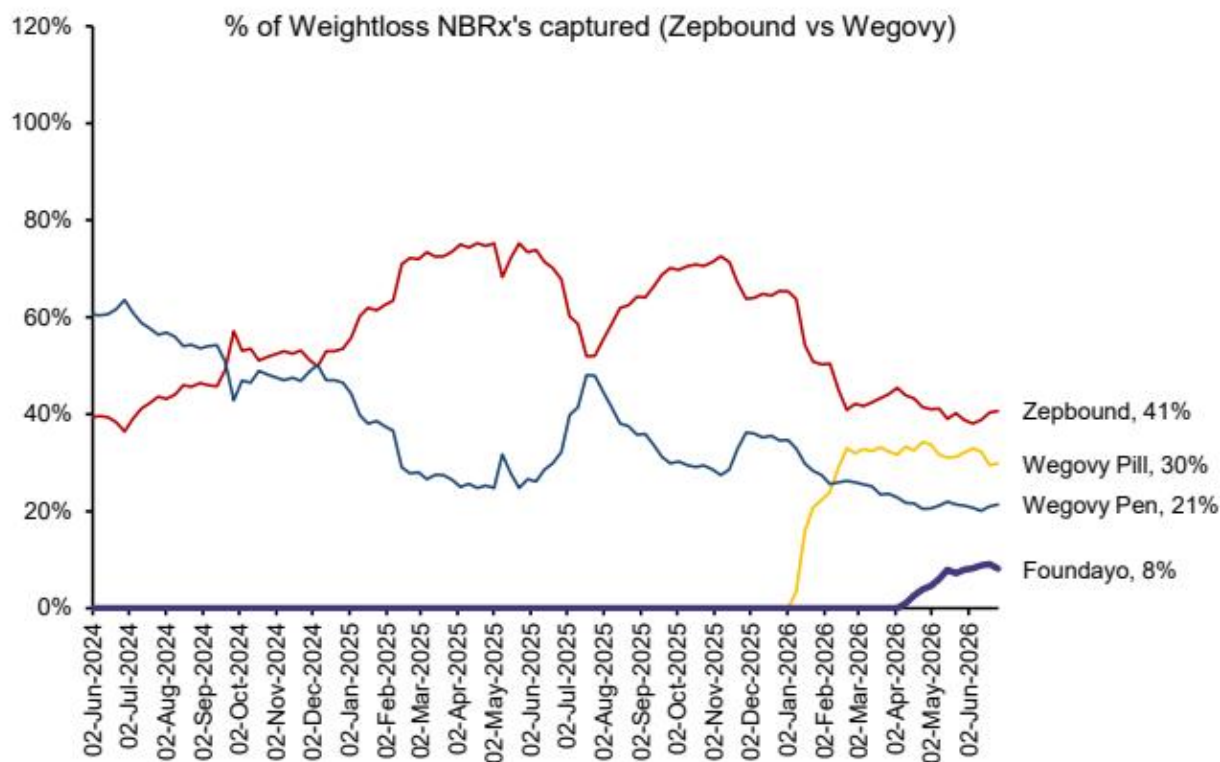
EXHIBIT 25: LLY 对比 Novo 在 NBRx 中的份额占比



图表 20

数据截至 6 月 26 日当周 来源：IQVIA, Bernstein 分析

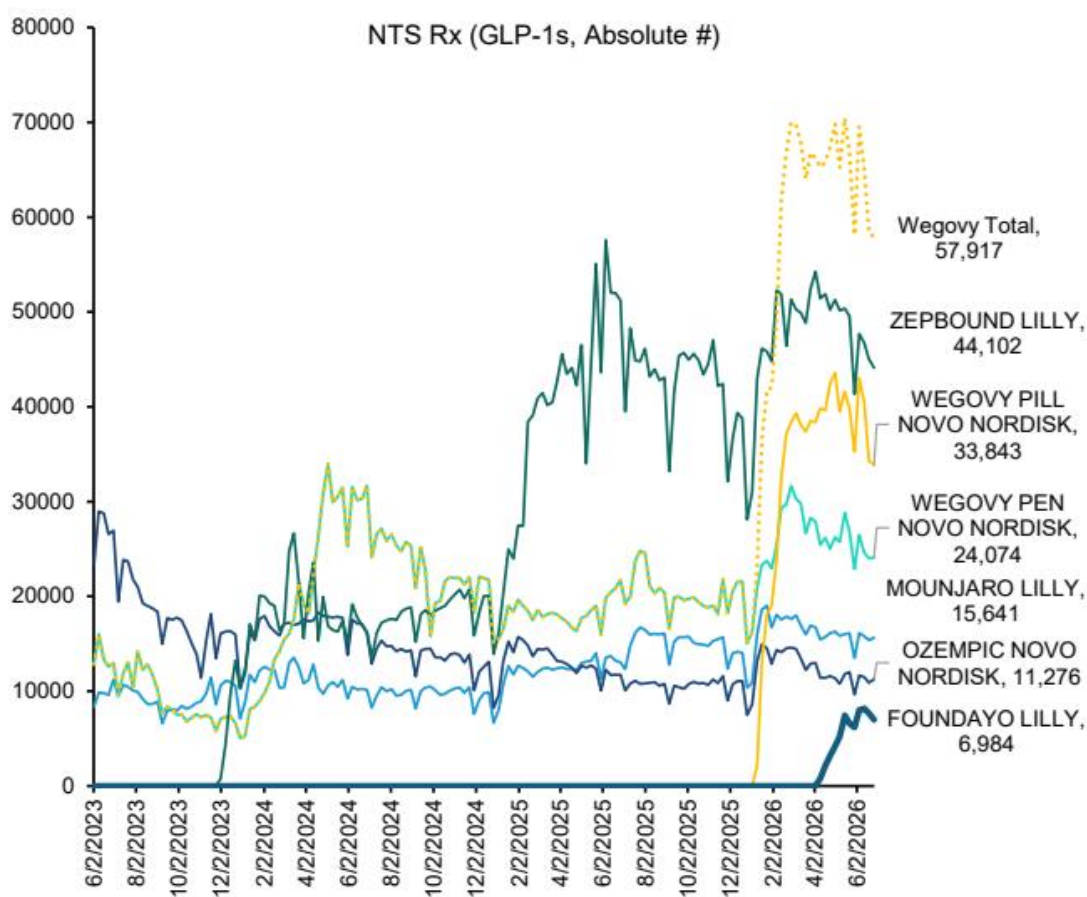
EXHIBIT 26:Wegovy 片剂正在占据减肥药 NBRx 的份额



图表 21

数据截至 6 月 26 日当周 来源：IQVIA, Bernstein 分析

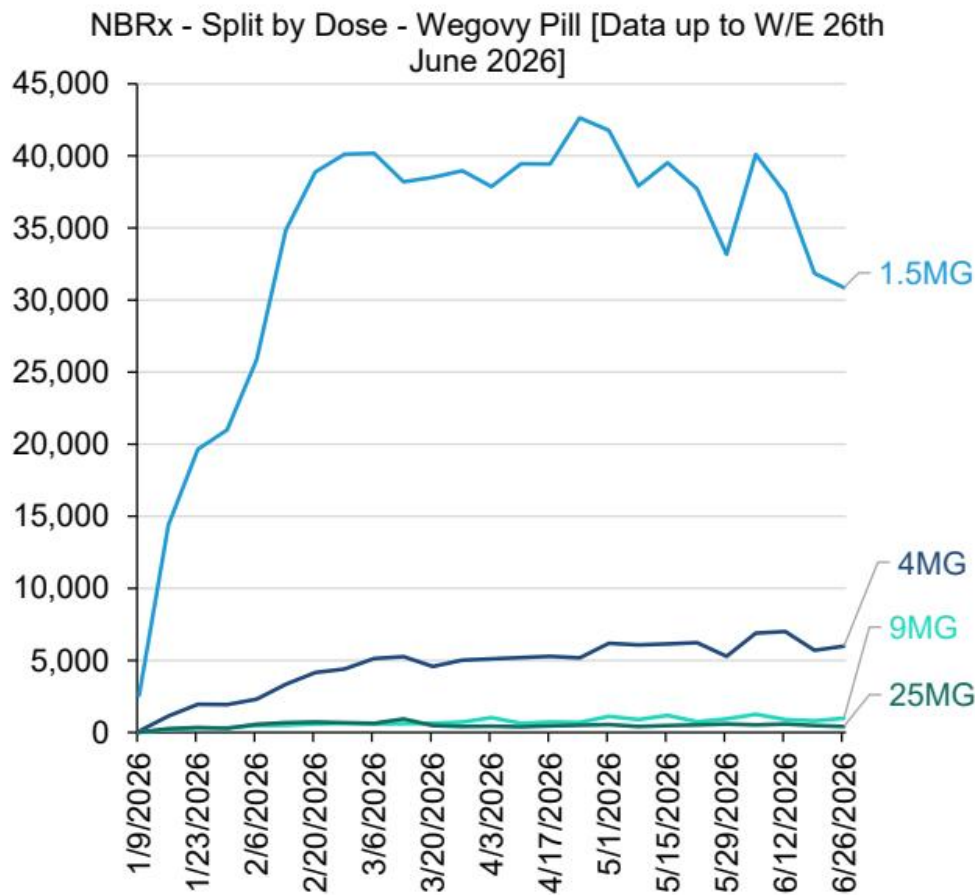
EXHIBIT 27:新治疗启动——处方——GLP-1



图表 22

来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 28:Wegovy Pill 起始剂量的 NBRx 似乎呈下降趋势



图表 23

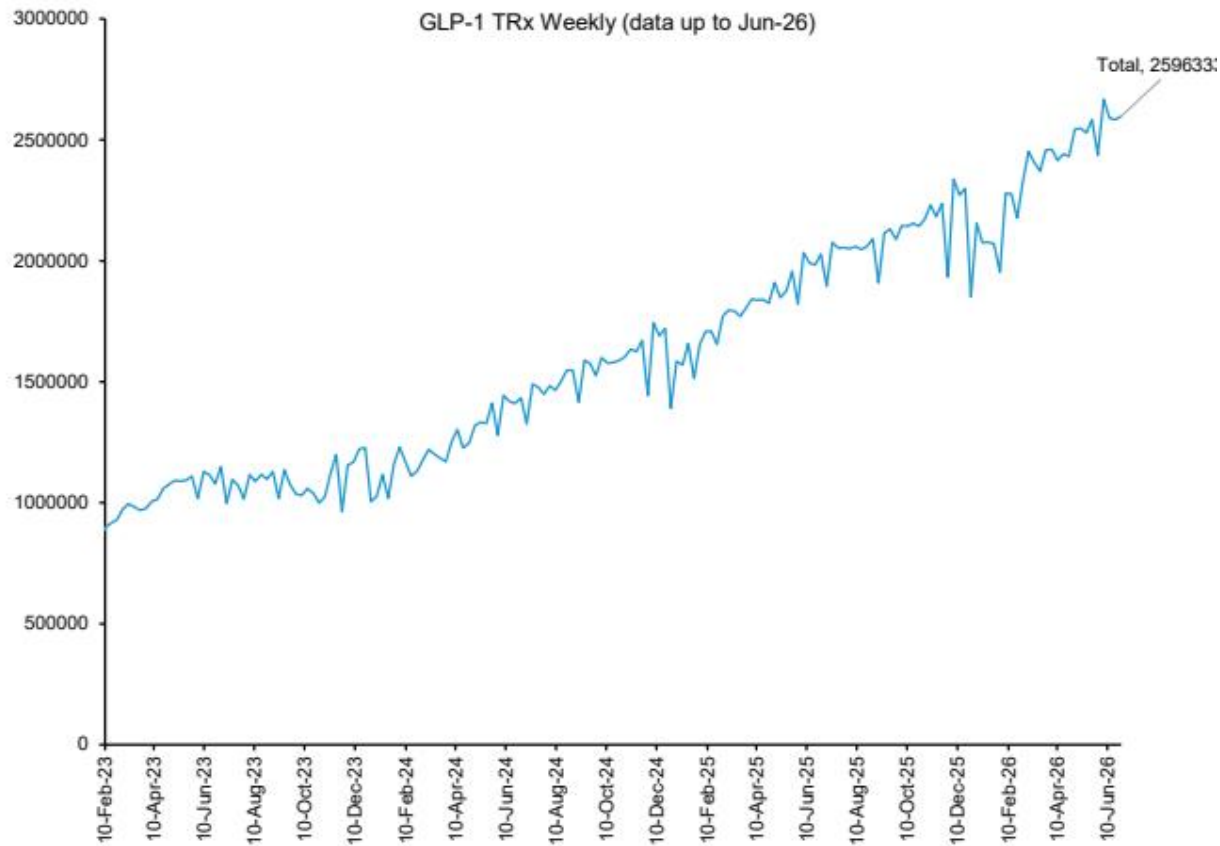
来源：IQVIA, Bernstein 分析

来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 31:TRx 4 周增长率

来源：IQVIA, Bernstein 分析

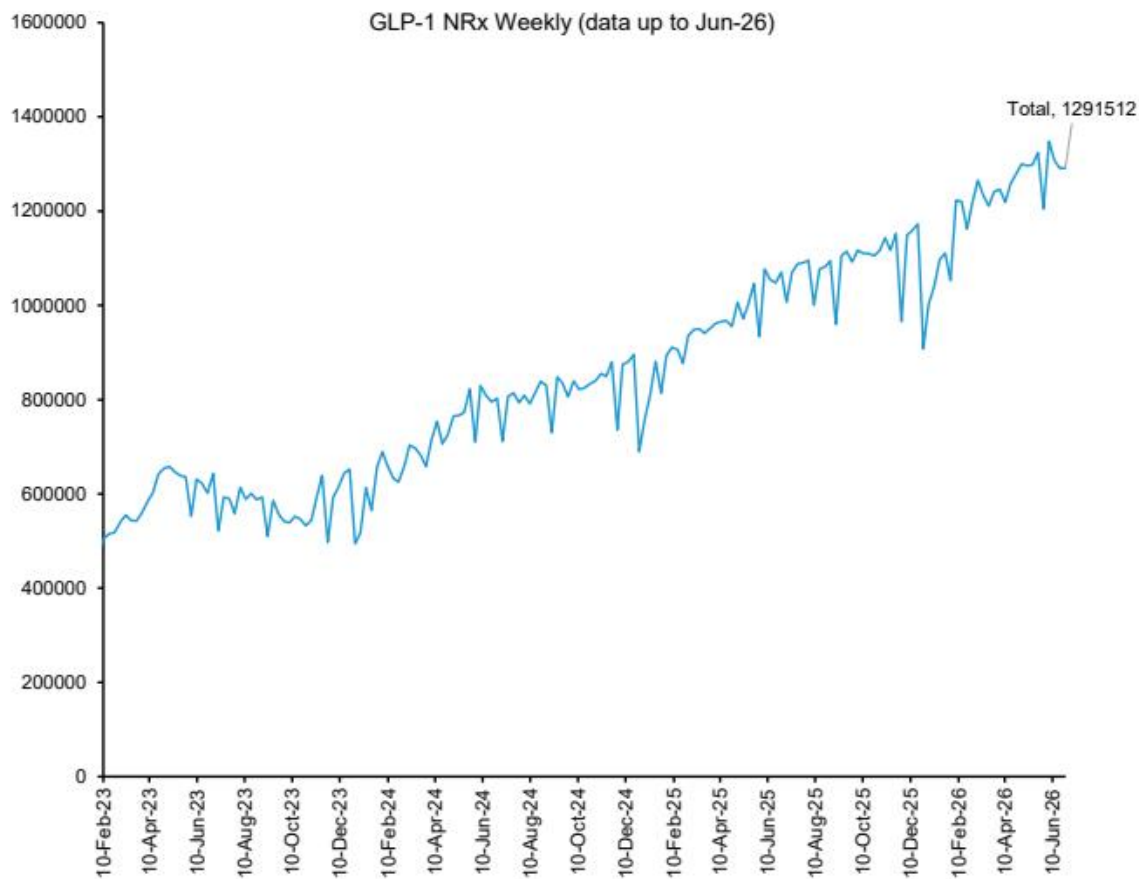
总 GLP-1 处方趋势 EXHIBIT 32:总 GLP-1 周度 TRx



图表 24

来源：IQVIA, Bernstein 分析

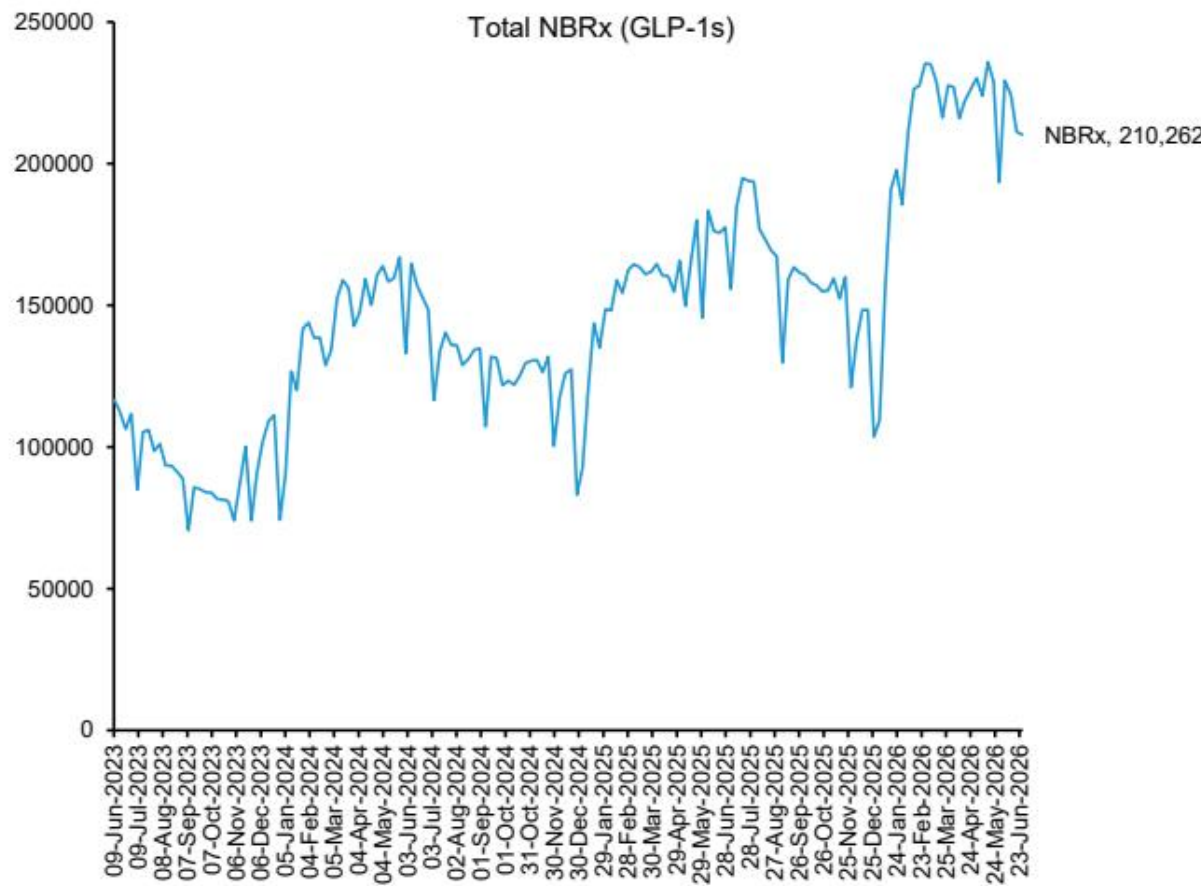
EXHIBIT 33:总 GLP-1 周度 NRx



图表 25

来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 34:GLP-1 新增患者数量仍处于高位



图表 26

数据截至 6 月 26 日当周 来源：IQVIA, Bernstein 分析

GLP-1 市场份额动态

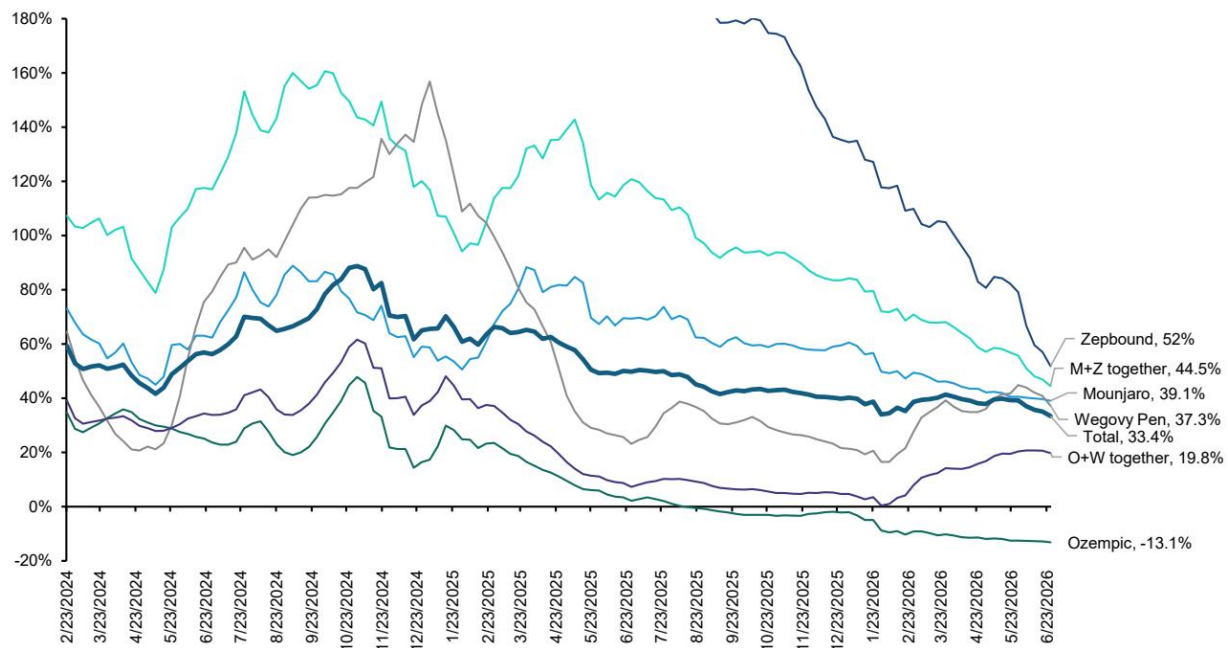
EXHIBIT 35:市场份额演变 (TRx)

EXHIBIT 36:上周市场份额演变

2,473,211 来源：IQVIA, Bernstein 分析

来源：IQVIA, Bernstein 分析

同比增长趋势 EXHIBIT 37:GLP-1 滚动 4 周同比销量增长



图表 27

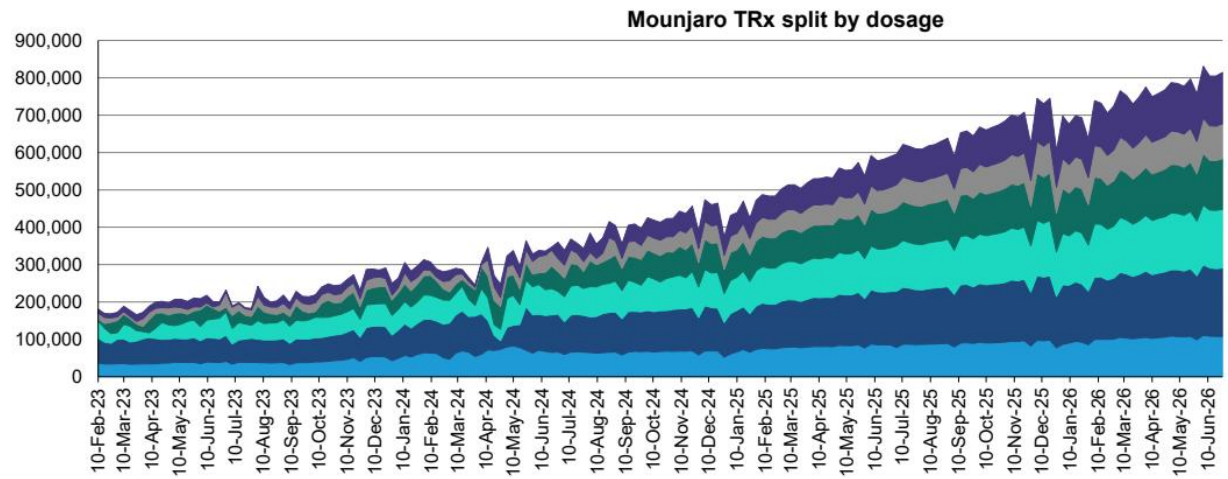
来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 38:TRx 4 周增长率对比去年同期

来源：IQVIA, Bernstein 分析

按剂量划分的 GLP-1 处方量 (TRX)

EXHIBIT 39:Mounjaro 按剂量划分的 TRx



图表 28

来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 40:Zepbound 按剂量划分的 TRx 来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 41:Ozempic 按剂量划分的 TRx 来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 42:Wegovy 按剂量划分的 TRx 来源：IQVIA, Bernstein 分析

- OZEMPIC NOVO NORDISK 8MG/3ML(2MG)
- OZEMPIC NOVO NORDISK 4MG/3ML(1MG)
- OZEMPIC NOVO NORDISK 2MG/3ML(0.25-0.5MG)
- OZEMPIC NOVO NORDISK 2MG/1.5ML(1MG)

- OZEMPIC NOVO NORDISK 2MG/1.5ML(0.25-0.5MG)
- WEGOVY PEN NOVO NORDISK 2.4MG/0.75ML
- WEGOVY PEN NOVO NORDISK 1.7MG/0.75ML
- WEGOVY PEN NOVO NORDISK 1MG/0.5ML
- WEGOVY PEN NOVO NORDISK 0.5MG/0.5ML
- WEGOVY PEN NOVO NORDISK 0.25MG/0.5ML

EXHIBIT 43:Wegovy Pill 按剂量划分的 TRx 来源：IQVIA, Bernstein 分析

EXHIBIT 44:Foundayo 按剂量划分的 TRx 来源：IQVIA, Bernstein 分析

IQVIA 处方指标：快速参考指南

核心公式：公司情况更新

每张已配药处方都汇总到 TRx 中。有两种分解方式

\- $TRx = NRx + RRx$ （新处方 + 续方）

\- $TRx = NBRx + CBRx$ （新品牌处方 + 持续处方）

处方量指标：公司情况更新

TRx — 总处方量

所有已配药处方——新处方和续方合并计算。顶层总量指标。

NRx — 新处方

药剂师配发的新处方。包括当患者已用完授权续药次数并收到新的处方编号以继续现有治疗时所开具的处方。

RRx — 续方处方

药剂师配发的授权续方处方，数据来自计算机化药房样本。

NBRx — 新品牌处方

针对首次开始使用特定品牌的患者所开具的处方，该患者在过去的 12 个月内（回溯期）未使用过该品牌。

CBRx — 持续处方

在过去12个月（回溯期）内与持续使用某产品相关的所有处方。包括授权续方以及患者续药用完时开具的新处方。

NBRX 子类别

NBRx（新品牌处方）由两个互斥的患者群体组成

NTS Rx — 新治疗启动处方

- 患者在该治疗类别中的首张处方；具体指在指定回溯期内，患者未曾配取过任何属于USC 3或USC 4相关定义市场的治疗药物，而为其配发的处方。

转换/加用处方

- 患者对该品牌是新的，但在回溯期内曾配取过同一治疗类别（USC3或USC4）中的其他药物。
- 涵盖两种情况
- 转换：患者从竞品品牌转向该品牌。
- 加用：患者在现有同类治疗基础上加用该品牌。

$NBRx = NTS Rx + \text{转换/加用处方}$

需要了解的关键区别

NRx 与 NBRx

- NRx 统计任何新处方，包括为续药用完的患者开具的续方——患者可能已长期使用该药物。
- NBRx 更为严格：仅统计过去12个月内未曾使用过该品牌的患者，是衡量患者获取的真实指标。

RRx 与 CBRx

- RRx 仅统计授权续方。
- CBRx 范围更广——包括续方以及为续药用完但仍在继续治疗的患者开具的续方。

回溯期：公司情况更新

- 用于区分NTS与转换/加用的标准回溯期为12个月。
- 某些急性治疗类别使用1个月回溯期，以更好地反映短期疗程模式。
- 采用1个月回溯期的急性类别包括抗感染药、抗生素和麻醉剂。

此前GLP1追踪报告

- 2026年6月26日 - LLY：调整Foundayo全年预测及GLP-1追踪 • 2026年6月22日 - GLP-1追踪：相对稳定的一周；Foundayo的IQVIA捕获率强劲（QTD约90%）（截至6月12日当周） • 2026年6月12日 - GLP-1追踪：Zepbound周TRx创历史新高，处方在假期后恢复（截至6月5日当周） • 2026年6月5日 - GLP-1追踪：长周末影响周处方量（截至5月29日当周）
- 2026年5月29日 - GLP-1追踪：IQVIA报告噪音影响Foundayo，类别TRx/NRx继续创历史新高（截至5月22日当周）
- 2026年5月22日 - GLP-1追踪：Wegovy Pill获EMA批准，Foundayo在老年人中有效（截至5月15日当周） • 2026年5月15日 - GLP-1追踪：Wegovy Pill首次出现环比下降（截至5月8日当周）
- 2026年5月8日 - GLP-1追踪：Zepbound数据波动；Foundayo从每日到每周的转换率终于达到19%的相关性（截至5月1日当周）
- 2026年5月1日 - GLP-1追踪：Zepbound周环比波动可能由邮件渠道漏报驱动（截至4月24日当周） • 2026年4月24日 - GLP-1追踪：Foundayo第二周 - 处方量落后于同行，但捕获率可能波动（截至4月17日当周） • 2026年4月17日 - GLP-1追踪：强劲开局 - Foundayo仅两个真实上市日即获1390 TRx（截至4月10日当周） • 2026年4月10日 - GLP-1追踪：Novo药片在Foundayo上市前趋于平稳？（截至4月3日当周）
- 2026年4月6日 - GLP-1追踪：Wegovy药片垄断的最后一周（截至3月27日当周）
- 2026年3月27日 - GLP-1追踪：口服Wegovy周环比增长节奏变化，Zepbound新启动量仍高（截至3月20日当周）
- 2026年3月20日 - GLP-1追踪：处方量稳定在接近上周峰值水平；口服Wegovy周TRx增长趋稳（截至3月13日当周）

- 2026年3月13日 - GLP-1追踪：处方量和新患者数重回历史高位（截至3月6日当周）
- 2026年3月6日 - GLP-1追踪：周总TRx/NRx接近历史峰值，Zepbound强势回归（截至2月27日当周）
- 2026年3月2日 - GLP-1追踪：Wegovy药片通过新患者启动为Novo提供生命线（截至2月20日当周）
- 2026年2月23日 - GLP-1追踪：药片增长尚未蚕食Zepbound新患者（截至2月13日当周）
- 2026年2月13日 - GLP-1追踪：Zepbound达到TRx历史新高，口服GLP-1 uptake加速（截至2月6日当周）
- 2026年2月6日 - GLP-1追踪：GLP-1新患者启动量创历史新高（截至1月30日当周）
- 2026年1月30日 - GLP-1追踪：Wegovy药片热潮；水涨船高？（截至1月23日当周）
- 2026年1月23日 - GLP-1追踪：口服市场第二周强劲[1.8万张处方]，潜在患者兴趣创新高（截至1月16日当周）
- 2026年1月16日 - GLP-1追踪：首个肥胖症药片来了（截至1月9日当周）
- 2026年1月9日 - GLP-1追踪：Zepbound新年开局强劲，首批Wegovy药片数据预计下周公布（截至1月2日当周）
- 2025年12月26日 - GLP-1追踪：处方量小幅回升，Zepbound新患者趋势增强（截至12月19日当周）
- 2025年12月19日 - GLP-1追踪：节前处方量仍在调整（截至12月12日当周）
- 2025年12月12日 - GLP-1追踪：感恩节节后处方量反弹，Novo获取部分新患者份额（截至12月5日当周）
- 2025年12月5日 - GLP-1追踪：感恩节影响总处方量；降价增加Wegovy患者启动（截至11月28日当周）
- 2025年11月28日 - GLP-1追踪：总处方量恢复增长，Zepbound有利的转换动态持续（截至11月21日当周）
- 2025年11月21日 - GLP-1追踪：Zepbound新患者趋势积极（截至11月14日当周）
- 2025年11月14日 - GLP-1追踪：处方量增长加速，Lilly凭借Zepbound强势继续扩大份额（截至11月7日当周）
- 2025年11月7日 - GLP-1追踪：处方量恢复增长，Lilly凭借Zepbound重获份额（截至10月31日当周）
- 2025年10月31日 - GLP-1追踪：处方量仍波动，但LLY与NOVO趋势一致（截至10月24日当周）
- 2025年10月24日 - GLP-1追踪：Zepbound突破持续；占据70%的新减肥患者（截至10月17日当周）
- 2025年10月10日 - GLP-1追踪：处方量持续上升，Zepbound肥胖症份额迈向69-70%（截至10月3日当周）
- 2025年10月3日 - GLP-1追踪：Lilly重获动力，Novo失势（截至9月26日当周）
- 2025年9月19日 - GLP-1追踪：Wegovy转换风波明显结束（截至9月12日当周）
- 2025年9月12日 - GLP-1追踪：劳动节降低处方量；Wegovy转换量低于Zepbound（截至9月5日当周）
- 2025年9月5日 - GLP-1追踪：WHO宣布GLP-1为基本药物（截至8月29日当周）
- 2025年8月29日 - GLP-1追踪：Wegovy趋平，Zepbound仍低于CVS变更前水平（截至8月22日当周）
- 2025年8月22日 - GLP-1追踪：Semaglutide转换节奏变化（截至8月15日当周）
- 2025年8月15日 - GLP-1追踪：Wegovy趋于稳定？以及Zepbound报告问题（截至8月8日当周）
- 2025年8月8日 - GLP-1追踪：Sema转换持续缓解（截至8月1日当周）
- 2025年8月1日 - GLP-1追踪：Wegovy转换率下降，Zepbound份额开始反弹（截至7月25日当周）
- 2025年7月25日 - GLP-1追踪：Wegovy继续受益于CVS转换（截至7月18日当周）
- 2025年7月11日 - GLP-1追踪：Mounjaro是否是Wegovy CVS优选地位的真实受益者？[截至7月4日当周]
- 2025年7月4日 - GLP-1追踪：Lilly上涨，随后处方量可能波动[截至6月27日当周]
- 2025年6月27日 - GLP-1追踪：周环比Wegovy上涨，Zepbound下跌 - [截至6月20日当周]
- 2025年6月23日 - GLP-1追踪：Novo尚未反弹[截至6月13日当周]
- 2025年6月13日 - GLP-1追踪：Zepbound持续推动礼来增长 [截至6月6日当周]
- \- 2025年6月6日 - GLP-1追踪：市场处方量走低，但同比仍增长 [截至5月30日当周]
- 2025年5月30日 - GLP-1追踪：Zepbound持续飙升，部分销量仍有待IQVIA验证 [截至5月23日当周]
- 2025年5月23日 - GLP-1追踪：尽管Zepbound数据问题持续，礼来增长依旧 [截至5月16日当周]
- 2025年5月19日 - GLP-1追踪：Zepbound总处方量下降（IQVIA存在少报） [截至5月9日当周]
- 2025年5月13日 - GLP-1追踪：总处方量跃升，但礼来增幅超过诺和诺德 [截至5月2日当周]
- 2025年5月5日 - GLP-1追踪：总处方量周度走软，但礼来份额仍在增长 [截至4月25日当周]

- 2025年4月28日 - GLP1追踪：礼来份额微幅上升，增长依然强劲 [截至4月18日当周]
- \- 2025年4月21日 - GLP1追踪：故事重演——礼来持续夺取份额（52%），增速快于供应指引及诺和诺德 [截至4月11日当周]
- \- 2025年4月14日 - GLP1追踪：礼来持续夺取份额，增速快于供应指引及诺和诺德 [截至4月4日当周]
- \- 2025年4月4日 -
GLP1追踪：Medicare排除条款快评；处方量增长回归，礼来驱动增长，诺和诺德现金支付渠道或未显现 [截至3月28日当周]
- \- 2025年3月31日 - GLP1追踪：替尔泊肽处方量持续展现优越性，等待观察诺和诺德现金支付影响 [截至3月21日当周]
- \- 2025年3月24日 - GLP1追踪：近期趋势延续，但礼来市场份额扩张由Mounjaro（而非Zepbound）驱动 [截至3月14日当周]
- 2025年3月17日 - GLP1追踪：礼来占据多数份额及瑞他鲁肽抗癌潜力 [截至3月7日当周]
- 2025年3月10日 - GLP1追踪：礼来持续超越诺和诺德增长，市场份额逼近50% [截至2月28日当周]
- \- 2025年3月3日 - GLP1追踪：礼来持续超越诺和诺德增长，市场份额逼近持平（49.1%） [截至2月21日当周]
- \- 2025年2月25日 - GLP1追踪：Zepbound宣布降价，LillyDirect可见度提升，尚未观察到司美格鲁肽起始剂量增加